MATRIZ DE PROFICIÊNCIA

ITEM 4 — PRECEPTORIA E CAMPOS DE PRÁTICA

Do campo assistencial ao ambiente educacional que produz competência

Proposta para o Percurso da Proficiência — Medicina

1. O que o Item 4 precisa garantir?

- Campos de prática seguros, qualificados e intencionalmente educacionais, alinhados às competências previstas na matriz de proficiência e às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina.
- Preceptores com competência clínica e pedagógica para supervisionar, observar, avaliar e oferecer feedback.
- Proporcionar ao estudante exposição progressiva e diversificada às situações clínicas, procedimentos e cenários de atenção à saúde essenciais para o desenvolvimento das competências previstas em cada etapa da formação.
- Progressão da autonomia de acordo com a competência demonstrada — e não apenas com o tempo de curso.
- Produção e registro de evidências de desempenho que alimentem as avaliações práticas e decisões acadêmicas.

Proficiência = saber + saber fazer + demonstrar desempenho adequado no contexto real de prática

2. Cadeia da Proficiência no Item 4

O foco deixa de ser apenas “ter campo e preceptor” e passa a ser demonstrar o resultado educacional.



- Cada elo precisa ser mensurável.
- Fragilidades em oportunidade clínica, supervisão ou feedback comprometem a aquisição da competência.
- O Item 4 produz as evidências que serão consolidadas no Item 5 — Avaliações de Aptidões Práticas.

3. Níveis de maturidade da matriz

Nível	Denominação	Caracterização
1	Inicial	Processo inexistente, informal ou dependente de iniciativas individuais.
2	Em desenvolvimento	Há iniciativas, porém sem aplicação uniforme ou monitoramento sistemático.
3	Estruturado	Processo institucionalizado, padronizado e aplicado regularmente.
4	Proficiente	Processo consolidado, monitorado e orientado por resultados educacionais.
5	Excelência	Processo integrado, baseado em evidências e submetido à melhoria contínua.

4. Dimensões da matriz — estrutura e experiência clínica

Dimensão	O que deve ser demonstrado
1. Qualificação do preceptor	Competência clínica + formação pedagógica para supervisão, feedback e avaliação.
2. Alinhamento curricular	Conhecimento das competências, objetivos e atividades esperadas no rodízio.
3. Qualidade do campo	Infraestrutura, segurança, volume e diversidade assistencial adequados.
4. Exposição clínica	Contato suficiente com condições, procedimentos e situações essenciais.
5. Supervisão clínica	Supervisão proporcional à complexidade e à competência do estudante.
6. Autonomia progressiva	Responsabilidade crescente baseada em desempenho e níveis de confiança/entrustable. .

5. Dimensões da matriz — avaliação, feedback e ambiente

Dimensão	O que deve ser demonstrado
7. Observação direta	Desempenho observado repetidamente, por diferentes preceptores e situações.
8. Feedback	Específico, baseado em comportamento e com plano de melhoria.
9. Avaliação no trabalho	Mini-CEX, DOPS, discussão de caso, EPAs, avaliação 360° e instrumentos equivalentes.
10. Ambiente educacional	Respeito, ética e segurança psicológica para perguntar, reconhecer limites e pedir ajuda.
11. Integração com a equipe	Papel definido e participação progressiva no cuidado e na tomada de decisão.
12. Melhoria contínua	Avaliação de preceptores e campos com indicadores, intervenção e reavaliação.

6. Proposta de pesos para o Índice de Proficiência

Dimensão	Peso	Dimensão	Peso
Qualificação do preceptor	10%	Observação direta	10%
Alinhamento curricular	8%	Feedback	10%
Qualidade do campo	10%	Avaliação no ambiente de trabalho	8%
Exposição clínica	10%	Ambiente educacional	5%
Supervisão clínica	12%	Integração com equipe	3%
Autonomia progressiva	10%	Monitoramento/melhoria contínua	4%

Maior peso para os elementos que transformam assistência em aprendizagem: supervisão, exposição, observação, feedback e autonomia.

7. Indicadores-chave para acompanhamento

Indicador	Exemplo de medida
Preceptores capacitados	% capacitados em preceptoria/educação médica nos últimos 24 meses
Alinhamento ao rodízio	% que conhecem formalmente competências e objetivos
Qualidade dos campos	% de campos aprovados em checklist institucional
Exposição clínica	% de estudantes que atingem experiências clínicas mínimas previstas
Observação direta	% com número mínimo de observações registradas por rodízio
Feedback	% de avaliações práticas acompanhadas de feedback documentado
Autonomia	% com progressão demonstrada nos níveis de supervisão
Percepção discente	Satisfação com preceptoria + ambiente de aprendizagem
Melhoria	% de campos/preceptores frágeis com plano de ação e reavaliação

8. Escore final e tomada de decisão

Resultado	Classificação	Conduta
< 50%	Crítico	Intervenção imediata
50–64%	Em desenvolvimento	Plano estruturado de melhoria
65–79%	Estruturado	Consolidar processos
80–89%	PROFICIENTE	Manter, monitorar e aperfeiçoar
≥ 90%	EXCELÊNCIA	Benchmark institucional

Regra de segurança: não classificar como “Proficiente” se Supervisão Clínica, Qualidade do Campo ou Feedback estiverem abaixo do nível 3.

9. Como operacionalizar a matriz

Estrutura sugerida para aplicação por rodízio e campo de prática.

Campo da planilha	Finalidade
Dimensão / critério	Define o aspecto da proficiência avaliado
Indicador	Transforma o critério em medida objetiva
Meta	Estabelece o padrão esperado
Fonte de evidência	Checklist, avaliação discente, ficha, sistema, portfólio etc.
Periodicidade	Mensal, por rodízio, semestral ou anual
Responsável	Coordenação, estágio, preceptor, núcleo acadêmico etc.
Nível 1–5	Classifica a maturidade observada
Peso	Permite calcular o índice global
Plano de ação	Registra intervenção, responsável e prazo

10. Resultado esperado do Item 4

PRECEPTORIA + CAMPO DE PRÁTICA

não são apenas estruturas de apoio ao currículo

Constituem o ambiente onde a competência é desenvolvida, observada, retroalimentada e progressivamente confiada ao estudante.

- Item 4 → produz experiências e evidências de desempenho.
- Item 5 → consolida e interpreta essas evidências nas avaliações de aptidões práticas.
- Resultado → progressão segura em direção à proficiência discente.

Referenciais conceituais

- Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina: formação por competências, integração ensino-serviço, supervisão e avaliação contínua.
- Educação Médica Baseada em Competências (CBME): progressão orientada por resultados e demonstração de desempenho.
- Entrustable Professional Activities (EPAs): integração entre competências e atividades profissionais com autonomia progressiva.
- Workplace-Based Assessment: observação direta, múltiplos avaliadores, feedback e acompanhamento longitudinal.
- Desenvolvimento docente/preceptoria: qualificação pedagógica e melhoria contínua dos ambientes clínicos de aprendizagem.

Apresentação-síntese para discussão e validação pelo GT de Proficiência.